פתיחת חזה בטראומה

שלומית אטלו

ראש צוות טראומה

הדסה עין כרם

הקדמה

- פתיחת חזה היא פעולה קיצונית אשר מתקיימת במצב של **דום לב כתוצאה מטראומה**
- ישנם קריטריונים מוגדרים להתאמת הפצועים לפרוצדורה
- הצלחה בביצוע פתיחת חזה תלויה מאוד בשיתוף פעולה בין אנשי הצוות, הכנה לקראת ביצוע הפרוצדורה וביצוע הפרוצדורה בצורה שקולה ככל הניתן
- אחוזי ההצלחה של פעולה זו **נמוכים** מאוד

סיכויי הישרדות לאחר פתיחת חזה בחבלה קהה

- <u>סימני חיים = פעילות חשמלית לבבית (PEA)</u>
- פצוע עם סימני חיים – 4.6% סיכויי הישרדות, 2.4% מתוכם עם תפקוד נוירולוגי מסוים
- פצוע ללא סימני חיים – 0.7%

סיכויי הישרדות לאחר פתיחת חזה בחבלה חודרת

- סימני חיים = פעילות חשמלית לבבית (PEA)
- פצוע עם חבלה **חודרת בחזה** וסימני חיים – 11%, ללא סימני חיים 8.3%
- פצוע עם חבלה **חודרת בבטן** עם סימני חיים 15%, ללא סימני חיים – 3%

פתיחת חזה בטראומה

מטרת הפרוצדורה:

- ביצוע עיסויים ישירות לשריר הלב
- הנחת חסם על האורטה היורדת (למנוע 'בזבוז' דם על איברי הבטן והגפיים התחתונות וליעד את הדם למוח, לב וריאות)

התוויות:

- חבלה (קהה או חודרת)
- אובדן סימני חיים
- הדרדרות משמעותית של פצוע עם סכנה לאובדן סימני חיים

הכנות לקראת פתיחת חזה

- **חובה לקרוא לאחראית משמרת וסיוע סיעודי נוסף!!**
- הזמנת אח/ות חדר ניתוח
  (להתקשר 74630 ולציין שפותחים חזה בטראומה וזקוקים לאחות)
- הכנת בנק הדם לקראת עירוי דם מאסיבי
- הזמנת עו"ס

- בחבלה **קהה** יש להכניס נקזי חזה דו"צ טרם פתיחת בית החזה (במקרה של חזה אוויר בלחץ, המטופל ישתפר לאחר נקז ו'תיחסך' פתיחת החזה)

ציוד שיש להכין

- עגלת פתיחת חזה (חדר VIP)
- עגלת החייאה (חדר VIP, במגירה תחתונה ישנם כפות פנימיות בהתוויה למתן שוק)
- כפפות וחלוק סטרילי
- כלורקסידין מרוכז (לשפוך על אזור החתך, טרם החתך)
- סקלפל (ערכת קמבו / עגלת פתיחת חזה)
- LEVEL 1 (חדר 1 / VIP)

תכולת עגלת פתיחת חזה (רלוונטית לאירוע)

- כלורקסידין מרוכז (על גבי העגלה מימין)
- סקלפל (על גבי העגלה מימין)
- ערכת פתיחת חזה (כלים של חדר ניתוח)
- רטרקטור (מפשק – מגירה ראשונה)
- תפר 'פרוליין' 2.0 לתפירת רקמת הלב (מגירה שנייה)
- פדי גאזה שמנים של חדר ניתוח (תחתית העגלה)

לאחר פתיחת חזה

במקרה של חזרת דופק ולחץ דם:

- יש לכסות את בית החזה בגאזות ומגבת סטרילית
- יש לרדת **במהירות** לחדר ניתוח, בסיוע הביטחון, להמשך טיפול
- שיחה עם המשפחה (צוות רפואי, סיעודי ועו"ס)

במקרה שדופק לא חוזר:

- יש ליצור קשר עם אח מתאם השתלות (קיריל 74081) לשקול המשך טיפול לצורך הנצלת איברים
- שיחה עם המשפחה (צוות רפואי, סיעודי ועו"ס)
- קביעת מוות, תפירת פצעים פתוחים (גם חתך פתיחת חזה), כתיבת תעודת פטירה

סרטון של פתיחת חזה על רקע טראומה

https://www.youtube.com/watch?v=8BlPxQI2C90

סיפור מקרה:

סיפור מקרה שהיה לפני כשנה מציג מצב בו ערנות, טיפול מהיר, ידע של שלבי הטיפול ושיתוף פעולה בין הצוותים הרפואיים, הסיעודיים והפרא רפואיים יכול להביא לטיפול המייטבי ביותר והצלת חיים!

התקבל דיווח על פצוע לאחר קטטה עם דקירה בחזה, לא יציב המודינמית

↓

פצוע עם חבלה חודרת בחזה, דופק לא נימוש.
החלו בפעולות החייאה והתארגנות לפתיחת חזה

↓

בוצעה פתיחת חזה ע"י ד"ר פישמן וד"ר שידלו בסיוע צוות סיעודי (תותח) ונצפה חור בלב

↓

הונח קלמפ על האורטה, בוצעו עיסויים פנימיים ישירות ללב ותוך כדי עיסויים נתפרה רקמת הלב

↓

למטופל חזר דופק (חלש) ולאחר מספר מנות דם והורד לחדר ניתוח לסיום הפרוצדורה

↓

ימים בודדים לאחר האירוע, מטופל יושב ער בטיפול נמרץ ואוכל בננה להנאתו. שוחרר מבית החולים ללא נזק מוחי

בהצלחה

זמינה לכל שאלה!